

Bevægeapparatets sygdomme

KØBENHAVNS UNIVERSITET



Kursus i Sygdomslære
Louise Heimdal Nilsson

Dagsorden

- Velkommen tilbage 😊
- Introduktion til kurset, pensum og eksamen
- Begreber
- Reumatiske sygdomme
- Inflammation
- Reumatoid artrit
- Osteoartrose
- Artrit vs. artrose
- Repetitionsspørgsmål + evt. gennemgang af eksamensopgave



Velkommen tilbage 😊

Jeg håber, at I synes eksamen i humanbiologi var en ok oplevelse 😊

Har I nogen kommentarer/ønsker/forslag til, hvordan cafétimerne skal være på dette kursus?

Jeg glæder mig til endnu et semester med jer!

Sygdomslære

Kursus i sygdomslære:

Introduktion til de hyppigste og væsentligste sygdomme i den vestlige befolkning

Formål – I skal kunne:

- Anvende medicinsk terminologi relateret til sygdomslære
- Kommunikere og samarbejde med sundhedspersonale og sundhedsvidenskabelige forskere
- IKKE arbejde klinisk med patienter selv

1. sem: Den raske krop

2. sem: Den syge krop

Læringsmål



Kursets læringsmål

Efter endt kursus forventes den studerende at have tilegnet sig følgende kvalifikationer:

Viden:

- For de hyppigste og væsentligste sygdomme i den vestlige befolkning:
 - Definere sygdommene.
 - Forklare patogenese og ætiologi.
 - Beskrive symptomer og fund, diagnostik, behandling, forebyggelse og byrde for patient og samfund.
 - Nævne forekomst, følgesygdomme og prognose.

Færdigheder:

- Anvende medicinsk terminologi relateret til sygdomslære.

Kompetencer:

- Kommunikere med sundhedspersonale og sundhedsvidenskabelige forskere.

Kursusoversigt

Undervisningen:

- 51 forelæsninger
- 23 SAU-timer
- 26 studiecafétimer fordelt på 13 gange

Eksamen:

- 3 timers skriftlig eksamen på KUA **uden hjælpemidler**
- Spørgsmål til 9 sygdomme fra forskellige specialer

Eksempel på eksamensspørgsmål:

Proximal femurfraktur

1. *Angiv forekomst samt om der er kønsforskel i forekomsten*
2. *Redegør for patogenesen*
3. *Angiv typiske symptomer og fund*
4. *Angiv diagnostik*
5. *Angiv en følgesygdom til brud på lårbenshalsen*
6. *Beskriv muligheder for forebyggelse*

Sygdomslære – hvad skal I lære?

For de hyppigste og væsentligste sygdomme i den vestlige befolkning:

- Definition
- Forekomst
- Patogenese
- Ætiologi
- Symptomer og fund
- Diagnostik
- Behandling
- Forebyggelse
- Prognose
- Følgetilstande
- Byrde for patient og samfund



Pensum

Else Marie Bladbjerg & Jens Brings Jacobsen

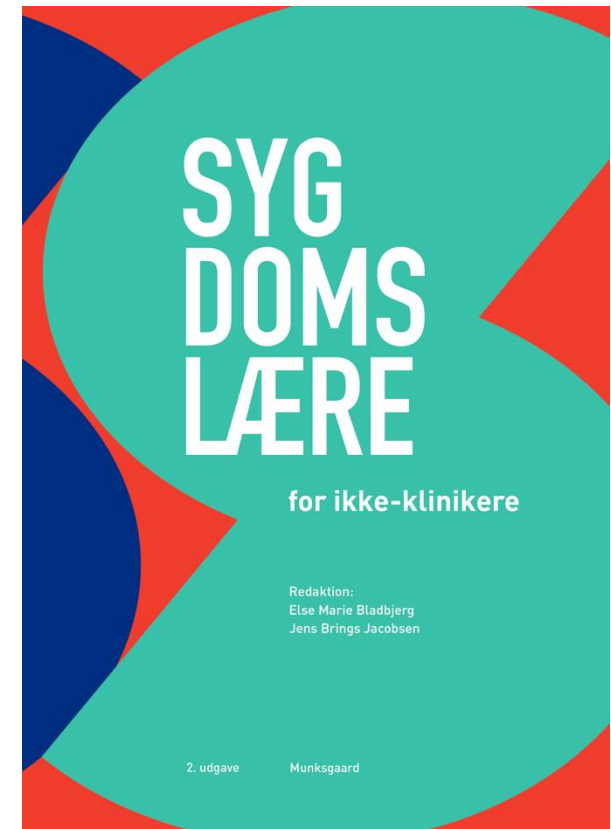
Sygdomslære for ikke-klinikere

2. udgave, Munksgaard

Obs! Udvalgte sygdomme fra hvert kapitel er ikke pensum

- Disse er markeret med **rød skrift** på Absalon under hvert modul

De lyseblå bokse, der handler om odontologi, er ikke pensum



Studiecaféerne i sygdomslære

The screenshot shows the Absalon LMS interface. On the left is a dark sidebar with navigation icons and labels: Home, Account, Dashboard, Courses, Calendar, Inbox, History, Search, Help (with a notification badge), Library, and Study info. The main content area is titled 'Sygdomslære med Louise' with a user icon. Below the title is the section '2. semester - Sygdomslære for ikke-klinikere'. It lists the instructor as Louise Heimdal Nilsson and provides an email address: louise.heimdal@sund.ku.dk. A welcome message follows, stating the user's name is Louise and they are the instructor for the course. It mentions that all course materials are gathered on this page. A link is provided for submitting questions or requests for repetition: <https://docs.google.com/document/d/1VRazGI8-nhV0m41k5Mmhe3sXbBqt1rVcncr7ETPYCupA/edit?usp=sharing>. Below this, two topics are listed: 'Bevægeapparatets sygdomme' and 'Neurologiske sygdomme', each with a link to preparation materials and a section for tasks. At the bottom of the sidebar, there is a search bar with the URL <https://absalon.ku.dk> and a search icon.

F24

Home

Announcements

Modules

People

Discussions

Grades

Chat

Rubrics

Quizzes

Item Banks

My Media

Media Gallery

Files

Collaborations

Syllabus

Assignments

Outcomes

BigBlueButton

Pages

Microsoft OneDrive

Syngdomslære med Louise

2. semester - Sygdomslære for ikke-klinikere

Underviser: Louise Heimdal Nilsson

Mail: louise.heimdal@sund.ku.dk

Velkommen til Studiecafé! på 2. semester :)

Mit navn er Louise, og jeg skal være jeres underviser til studiecaféerne i sygdomslære for ikke-klinikere.

Al materialet til studiecaféerne er samlet på denne side, og det vil blive lagt op løbende.

Hvis I har **spørgsmål, ønsker til repetition eller gennemgang af svære emner**, kan I skrive det i dette dokument: <https://docs.google.com/document/d/1VRazGI8-nhV0m41k5Mmhe3sXbBqt1rVcncr7ETPYCupA/edit?usp=sharing>

Bevægeapparatets sygdomme

Forberedelse: [Bevægeapparatets sygdomme - forberedelse](#)

Opgaver:

PP:

Neurologiske sygdomme

Forberedelse: [Neurologiske sygdomme - forberedelse](#)

Opgaver:

PP:

<https://absalon.ku.dk> search

Til hvert emne findes:

- Et opgaveark
- Et powerpoint
- Evt. en quiz

Husk også dokumentet, hvor I kan skrive ønsker til, hvad der skal gennemgås 😊

Studiecaféerne i sygdomslære

Generelt: Pensum omfatter rigtig mange sygdomme – vi gennemgår de 'største' i timerne.

1+2:	Bevægeapparatets sygdomme + intro
3+4:	Neurologiske sygdomme
5+6:	Psykiske sygdomme
7+8:	Endokrine sygdomme
9+10:	Hjerte-kar-sygdomme
11+12:	Blodsygdomme
13+14:	Lungesygdomme
15+16:	Allergiske sygdomme
17+18:	Mave-tarm-sygdomme
19+20:	Nyre- og urinvejssygdomme
21+22:	Gynækologiske sygdomme og obstetrik
23+24:	Infektionssygdomme
25+26:	Kræftsygdomme

Dagens opvarmning



Forklar begreberne:

- Definition Afgrænset videnskabelig beskrivelse på et par sætninger
- Forekomst Prævalens/hyppighed, kønsfordeling, debutalder
- Patogenese Biologiske mekanisme, der udvikler af sygdommen (processen rask → syg)
- Ætiologi Årsag til sygdommen (genetik, biologi, livsstil)
- Symptomer og fund Tegn på sygdom, som kan ses eller mærkes
- Diagnostik Hvordan diagnosen stilles (kriterier)
- Behandling Medicin, kirurgi, livsstilsændringer ...
- Forebyggelse Muligheder for at forhindre sygdommen i at opstå og/eller brede sig
- Prognose Forsøg på at forudsige udviklingen (mortalitet, remission, recidiv)
- Følgetilstande Tilstande, som opstår i tilknytning til sygdommen
- Byrde for patient og samfund Økonomisk, socialt, psykologisk

Begreber på kurset

Definition	Forekomst	Patogenese aetiologi	Symptomer	Fund	Parakliniske undersøgelser	Behandling	Følge- sygdomme	Prognose	Byrde
Kort, præcis definition af hvad sygdommen er	Er det en hyppig sygdom, en sjælden sygdom, eller en derimellem? Hvem rammes?	Hvad disponerer for sygdommen, hvordan opstår den, hvad går galt?	Hvad patienten kunne beklage sig over til lægen	Hvad lægen vil kunne se på patienten eller mærke sig frem til	Blodprøver, billeddiagnostik, <u>lungfunktionsundersøgelser</u> og så videre	Principper for behandling, medicin med videre	Sygdomme der hyppigere rammer patienter med denne sygdom	<u>Fremtidsudsigter</u> , <u>overlevelsesrate</u> , <u>helbredelsesrate</u> ?	Byrde for patient og/eller samfund

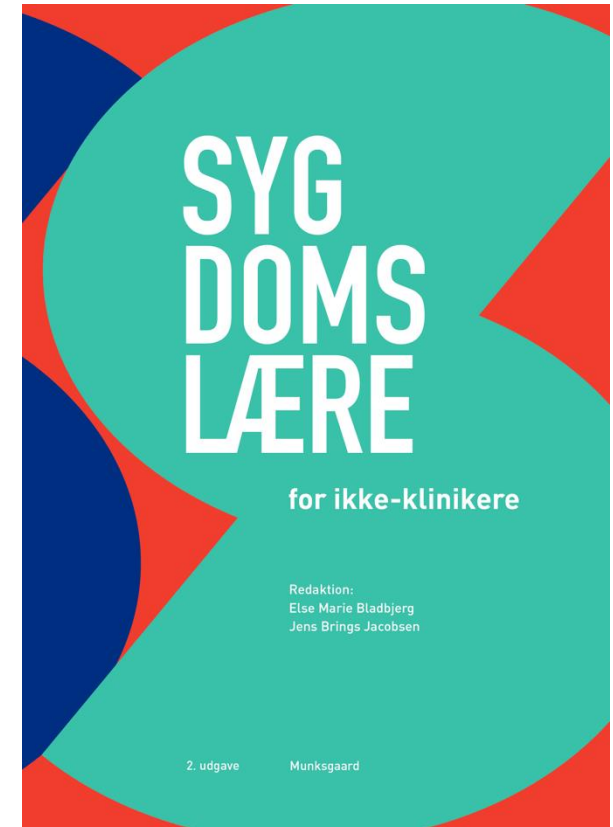
Dagens pensum

Else Marie Bladbjerg & Jens Brings Jacobsen

Sygdomslære for ikke-klinikere

2. udgave, Munksgaard

Kapitel 3 – Bevægeapparatets sygdomme (s. 29-73)
med undtagelser!



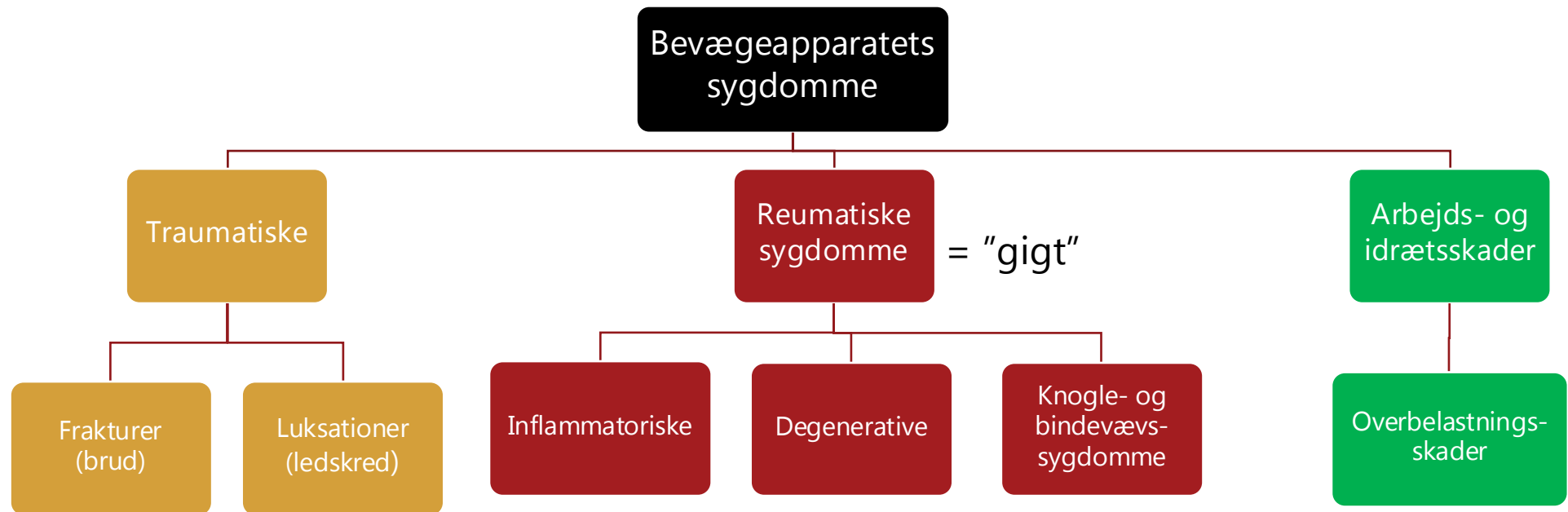
Bevægeapparatets sygdomme

- Reumatoid artrit
- Bechterews sygdom
- Psoriasis artrit
- Reaktiv artrit
- Sjögrens syndrom
- Polymyalgia reumatika
- Arthritis urica
- Osteoartrose
- Diskusprolaps
- Morbus Scheuermann
- Fibromyalgi
- Myoser
- Tendinitis
- Tendovaginitis
- Frakturer
- Proximal femurfraktur
- Distal radiusfraktur
- Humerus fraktur
- Skulderluksation

Medicinske præfikser og suffikser

-it, -itis	artr it , perikard it , pleur it , appendic it ...	Betændelse, inflammation i det pågældende organ
art- (articulatio)	ar trit, art rose	Led (vedrører led)
anti-	anti stof, anti inflammatorisk	Imod noget, modsætter noget
spondyl-	spondyl oartropati, spondyl itis	Vedrører ryghvirvlen, rygsøjlen

Sygdomme i bevægeapparatet (led, muskler, sener, knogler)



Reumatolog



Især sener, led, muskler (medicinske sygdomme i bevægeapparatet)

Ortopædkirurg



Især knogler (kirurgiske sygdomme i bevægeapparatet)

Opgave 1

Opgave 1

Angiv så mange reumatiske sygdomme, som du kan, og klassificer dem i undergrupperne inflammatoriske reumatiske sygdomme og degenerative reumatiske sygdomme

Reumatiske sygdomme – "gigt"

Inflammatoriske

Inflammatoriske ledlidelser

- Reumatoid artrit (leddegigt)

Spondyloartropatier (SpA)

- Bechterews sygdom (rygsøjlegigt)
- Psoriasisartrit (psoriasisgigt)
- Reaktiv artrit (reaktiv gigt)

Inflammatoriske systemsygdomme

- Sjögrens syndrom
- Polymyalgia reumatika (muskelgigt)

Krystalaflejringssygdomme

- Arthritis urica (urinsyregigt)

Degenerative

Degeneration i perifere led

- Osteoartrose (slidgigt)

Degenerative ryglidelser

- Diskusprolaps
- Morbus Scheuermann (rundryg)

Andre:

- Infektiøse artritter



Inflammatoriske sygdomme i bevægeapparatet

- **Reumatoid artrit**
- Bechterews sygdom
- Reaktiv artrit
- Arthritis urica



Opgave 2

Opgave 2

Redegør for, hvad inflammation er, og hvordan adskiller det sig fra infektion

Inflammation

Inflammation – "betændelse"

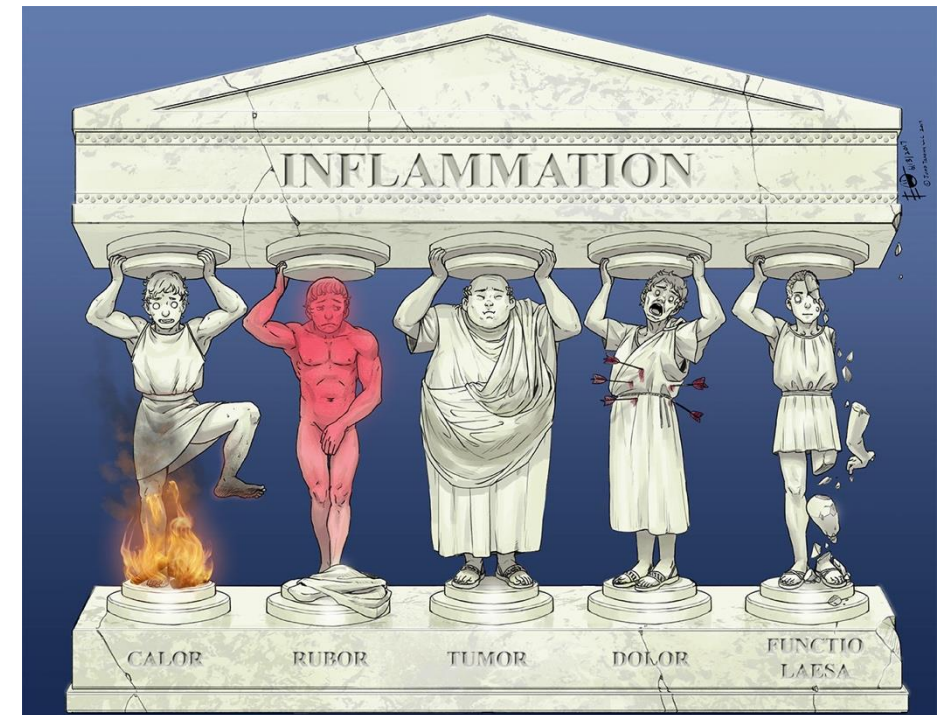
- En af kroppens forsvarsmekanismer på irritant, 'noget fremmed', celle- eller vævsskade osv.
- Rekruttering af hvide blodlegemer (leukocytter)
- Kroppen vil gerne afgrænse det beskadigede væv og uskadeliggøre den skadevoldende påvirkning -> angriber dette
- Kan forårsage vævsskade
- Inflammation forekommer altså ikke kun ved infektioner – det kan fx også opstå, hvis kroppens immunforsvar "tager fejl" i vurderingen af, hvad der er fremmed -> **autoimmune sygdomme**

Infektion

- Opstår ved indtrængen/invasion af **mikroorganismer** (bakterier, virus, parasitter)
- Kroppen reagerer på en infektion ved at starte en inflammation (betændelsesreaktion)

Kliniske tegn på inflammation

- Varme
- Rødme
- Hævelse
- Smerte
- Tab af funktion/stivhed



Opgave 3

Opgave 3

Redegør for reumatoid artrit (ægte leddegigt)

- Definition
- Forekomst
- Patogenese
- Ætiologi
- Symptomer og fund
- Diagnostik
- Behandling
- Forebyggelse
- Prognose
- Følgetilstande

Reumatoid artrit (leddegigt)

Definition:

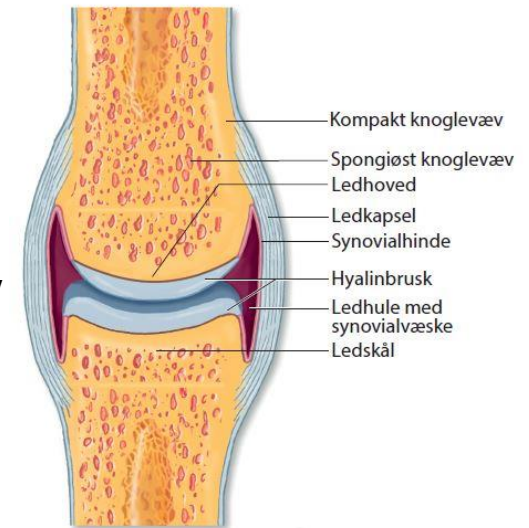
- Inflammatorisk lidelse som angriber synovialbeklædte strukturer (ægte led, sener, slimsække) og giver ledsvulst
- Rammer **symmetrisk**, ofte små led som hånd-, finger-, og tåled (men kan også ramme større led som skulder- og knæled)

Forekomst:

- Prævalens: 1% i den voksne befolkning
- Kvinde/mand ratio: 3/1
- Debuterer ofte i 20-40 års alderen

Patogenese:

- Hævelse af synovialis med polypagtige udvækster (pannus) på synovialis indeholdende inflammatorisk aktive celler
- Ubehandlet eroderes (bortgnaves) ledfladens underliggende væv (brusk og knogle) → erosioner



Ægte led / synovialled



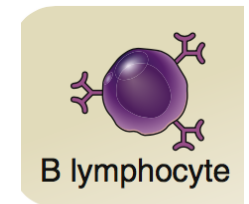
Erosioner på røntgenbillede

Reumatoid artrit (leddegigt)

Ætiologi:

Ukendt – men det antages at være en samspil mellem følgende:

- Genetiske faktorer (HLA vævstyper)
- Infektiøst agens (virus, bakterier) eller anden immunaktiverende mekanisme → kronisk inflammation (autoimmun)
- Rygning: Toksisk påvirkning → **citrullinering** af peptider → immunrespons
 - Aktivering af B- og T-celler
 - Dannelse af antistoffer mod citrullinerede peptider: **Anti-CCP** → inflammation
- Autoantistoffer (mod dele af egne IgG): **Reumafaktor**



Reumatoid artrit (leddegigt)

Symptomer og fund :

- Akut eller gradvist tiltagende ømhed af led
- Smerte ved anstrengelse
- Symmetriske angreb på håndled, knoed, fingrenes mellemlid og tæernes grundled
 - Evt. også angreb på større led: Knæ, skuldre
- Træthed
- Ledhævelse (ansamling af væske i leddet) og ødem i vævet omkring
- Ledstivhed (især om morgenen)
- Muskelsvaghed og -atrofi
- Instabilitet, bevægeindskrænkning, fejlstilling

Ekstraartikulære manifestationer:

- Seneskedehindebetændelse (tendovaginitis)
- Betændelse i slimsække (bursitis)
- Noduli rheumatici (gigtknuder – hævelser under huden)



Reumatoid artrit (leddegigt)

Diagnostik:

Mulighed 1: Klassifikationskriterier for RA

- Nyopstået synovitis (inflammation i ledhinden) i min. ét led, der ikke bedre kan forklares ved anden sygdom
- Der skal scores min. 6 ud af 10 point for at få diagnosen RA

Mulighed 2: Røntgenundersøgelse

- Længere sygehistorie forenelig med RA + karakteristiske forandringer på røntgenbillede
 - Erosioner
 - Udtynding af knoglerne op til leddene
 - Ledspalteforsnævring
 - Lednære cyster
 - Leddeformitet

Joint involvement	Score
• 1 medium-large joint	0
• 2-10 medium-large joints	1
• 1-3 small joints	2
• 4-10 small joints	3
• More than 10 small joints	5
Serology	
• RF (-) and anti-CCP (-)	0
• RF (+) or anti-CCP (+)	2
• High RF (+) or anti-CCP (+)	3
Duration of symptoms	
• < 6 weeks	0
• ≥ 6 weeks	1
Acute phase reactants	
• CRP and ESR within normal	0
• elevated CRP or ESR	1



Reumatoid artrit (leddegigt)

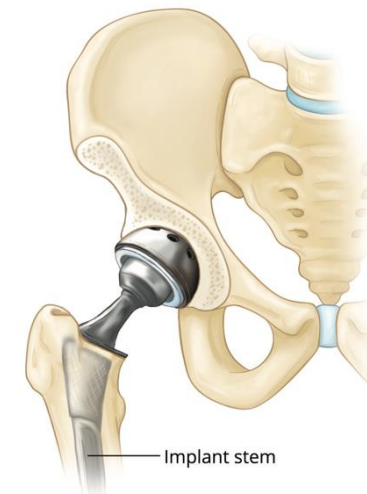
Behandling:

Farmakologisk:

- NSAID – non steroid anti-inflammatory drugs
 - Smertelindrende + antiinflammatorisk + antipyretisk
- Binyrebarkhormon
 - Meget symptomlindrende (antiinflammatorisk), men også mange bivirkninger
- Methotrexat
 - Kemoterapeutika som dæmper immunforsvaret
- Biologiske lægemidler
 - Antistoffer, der hæmmer cytokinet TNF-alfa, som indgår i den inflammatorisk proces

Non-farmakologisk

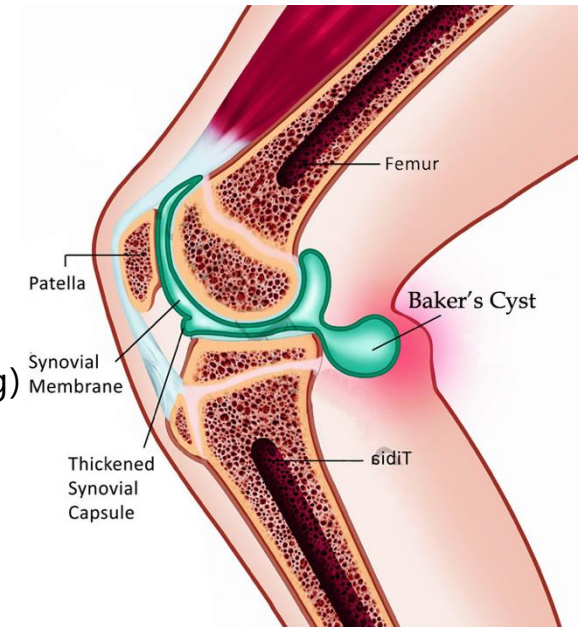
- Gigtskole
 - Oplysning, træning, compliance, ergoterpi etc.
- Operation (ved svære leddestruktioner)



Reumatoid artrit (leddegigt)

Følgetilstande:

- Delvis eller total seneruptur (hvis betændelsen gennem-eroderer sener)
- Bakers cyste (udposning af ledkapslen i knæhasen pga. væskeophobning)
- Infektion af led eller slimsæk
- Vaskulitis (karvægsbetændelse)
- Evt. perikarditis eller pleuritis



Forbyggelse

- Ikke mulig pga. ukendt ætiologi
- Undgå tobak

Prognose:

- Hyppigst en kronisk sygdom med livslangt forløb
- Ubehandlet: Tiltagende funktionstab, erosioner, fejlstilling
- Livslængden er afkortet med 10 år ved aktiv sygdom



Reumatoid artrit (leddegigt)

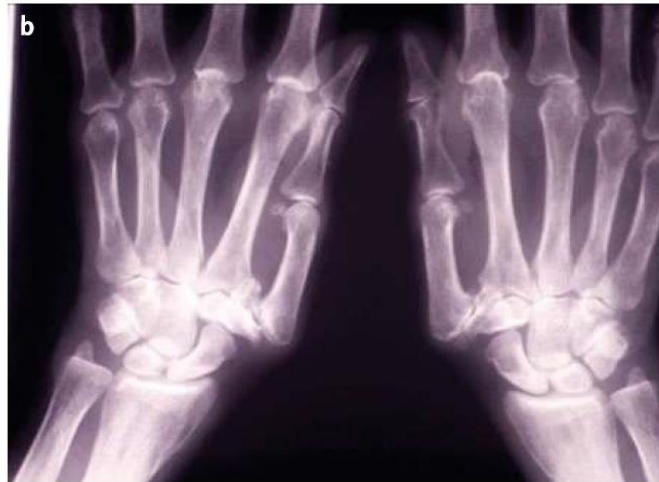
Take home message

- Autoimmun sygdom
- Prævalens er 1%, kvinde/mand ratio er 3/1
- Inflammatorisk angreb på synovialis- (ledhinde-) beklædte strukturer
- Symptomer: Ledhævelse, ledsmerter, morgenledstivhed og træthed
- Hyppigst hånd-, finger- og tåled
- Behandling: Medicinsk, træning, hjælpemidler



Degenerative sygdomme i bevægeapparatet

- **Osteoartrose**
- Diskusprolaps



Opgave 4

Opgave 4

Redegør for osteoartrose (slidgigt)

- Definition
- Forekomst
- Patogenese
- Ætiologi
- Symptomer og fund
- Diagnostik
- Behandling
- Forebyggelse
- Prognose
- Følgetilstande

Osteoartrose (slidgigt)

Definition

- Ledlidelse med smerter og/eller funktionsnedsættelse grundet degenerative forandringer i ledbrusk og lednær knogle

Forekomst

- Hyppigste lidelse i bevægeapparatet
- Stiger med alderen (50% af 50 årige, 90-100% af 80 årige)
- Kønsforskel fra led til led

Patogenese

- Slutprodukt af multifaktoriel skade
- Tab af brusk pga. flere brusknedbrydende enzymer
- Øget tæthed + væsketryk i underliggende knogle
- Afsmalning af ledspalte
- Cystedannelse + osteofytose kan forekomme



Osteoartrose (slidgigt)

Ætiologi

- Fejl- og overbelastning af leddet
- Arvelige faktorer
- Livsstil

Symptomer og fund

Mange – de vigtigste er:

- Smerter (først efter større anstrengelser, senere kommer klassisk belastningstriade)
- Funktionstab (grundet gradvist tab af muskelkraft pga. de andre faktorer)

Derudover kan der forekomme

- Ledstivhed
- Bevægeindskrænkning
- Skurren i leddet
- Ossøs hævelse (+ evt. ødem)
- Fejlstilling
- Ledspecifikke symptomer



Osteoartrose (slidgigt)

Diagnostik

Røntgenbillede med følgende forandringer

- Afsmalning af ledspalte (vigtigste)
- Derudover osteofytose, fortætning af knogle under ledflade, cystedannelse

Følgetilstande

- Fedme (grundet inaktivitet)

Behandling

- Vægttab, træning, smertestillende medicin
- Operation ved uholdbare gener

Forebyggelse

- Undgå fejl-/overbelastning
- Vægttab

Prognose

- Afhænger af opretholdelse af funktionsniveau (vigtigt for god prognose)



Opgave 5

Opgave 5

Redegør for forskellen mellem leddegigt (reumatoid artrit) og slidgigt (osteoartrose)

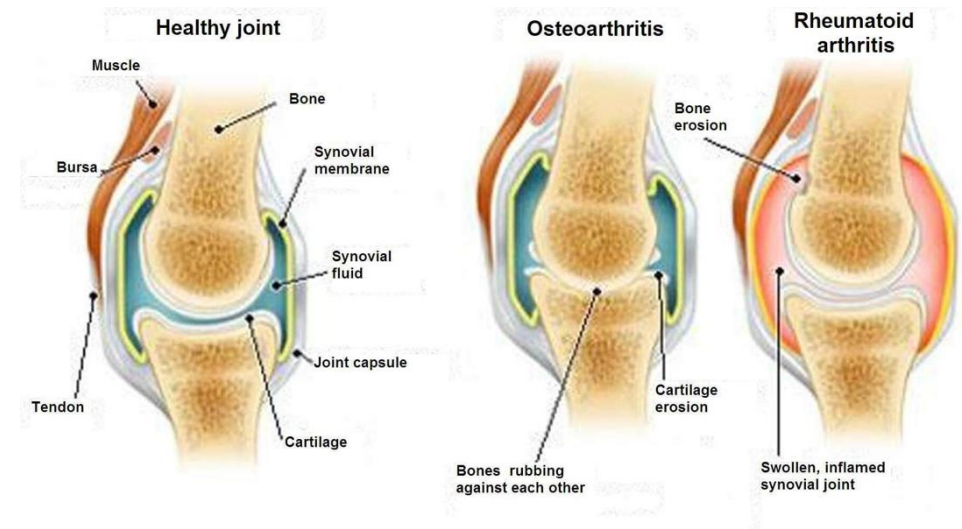
Leddegigt vs. slidgigt

Osteoartrose (slidgigt)

- Ledlidelse med **degenerative** forandringer i ledbrusk og lednære knogler
- Symptomer: Smerter, funktionsnedsættelse, ledstivhed, skurren, hævelse
 - **Belastningstriaden**: Igangsætningssmerter, lindring efter let aktivitet, smerter igen efter yderligere aktivitet
- Slutprodukt af multifaktorielle **skader og belastninger** på ledstrukturerne
- Tab af ledbrusk
- **Asymmetrisk** ledaffektion

Reumatoid artrit (leddegigt)

- **Autoimmun, inflammatorisk** ledlidelse der rammer synovialis-beklædte strukturer
- Symptomer: **Morgenstivhed**, træthed, ledsmerter
- **Symmetrisk** ledaffektion



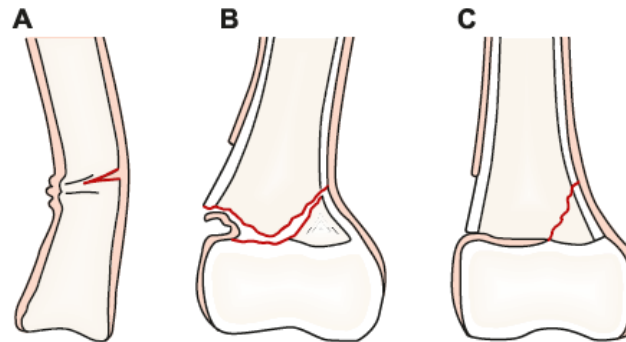
Normal & arthritic joints

Traumatiske sygdomme i bevægeapparatet

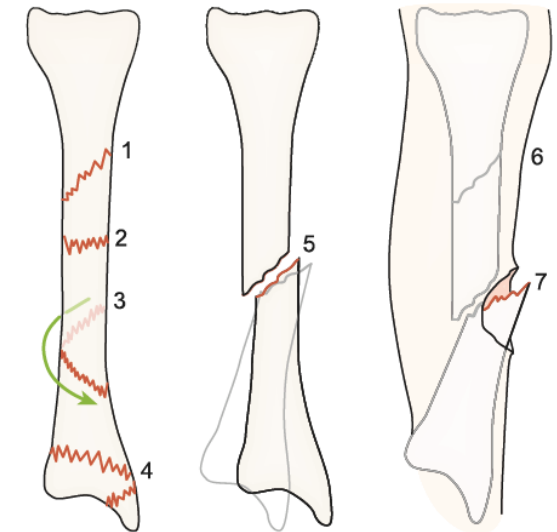
Frakturer (brud på knogle)

Typer af frakturer ud fra:

- Brudlinje
- Om frakturen er ekstra- eller intraartikulær (udenfor eller indeni et led)
- Om frakturen er dislokeret eller udislokeret
- Om frakturen er åben eller lukket (obs truet hud)



Figur 3.15. A) Hos børn kan der ses bøjningsbrud, Greenstick-fraktur, hvor knoglen ikke brækker helt over, men den ene del af corticalis holder. B) Epifysiolyse er epifyseskivelæsioner hos børn. C)



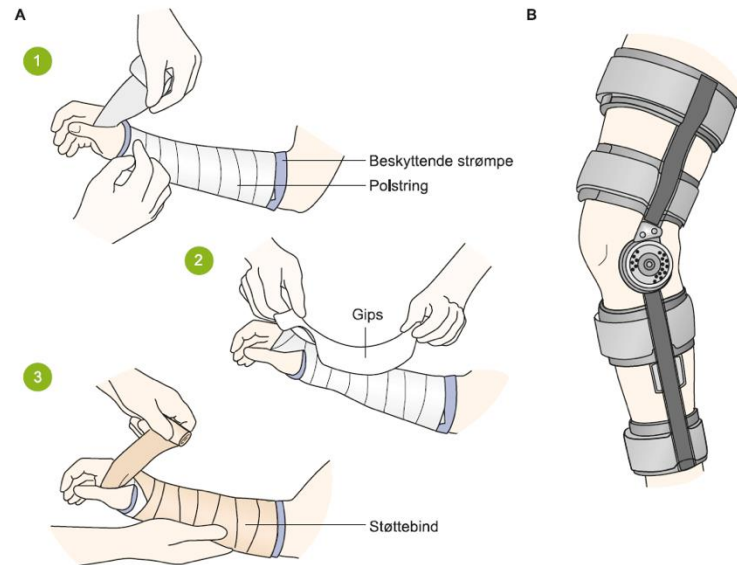
Figur 3.14. Frakturtyper. 1) Skråfraktur. 2) Tværfraktur. 3) Spiralfrakstur. 4) Ekstra eller intraartikulær fraktur. 5) Disloceret eller udisloceret fraktur. Afhængigt af om der også er hudlæsion, taler man om henholdsvis 6) lukket og 7) åben fraktur.

Traumatiske sygdomme i bevægeapparatet

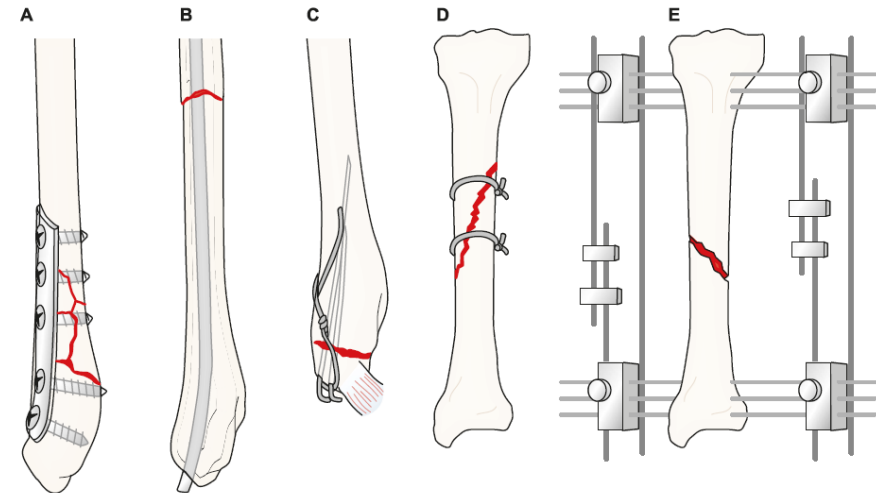
Frakturer (brud på knogle)

Behandling af frakturer

- Overordnet set skelnes mellem **konservativ behandling** og **operation**



Figur 3.17. Immobilisering. A) Klassisk gipsbandagering med (1) beskyttende strømpe, polstring og herefter (2) den stabiliserende gips (eller forskellige kunststoffer). (3) Bandageringen afsluttes med et støttebind. Man skal være opmærksom på ikke at stramme for meget, og i størkningsfasen må der ikke sættes fingre på bandagen, da dette giver trykmærker. B) Sidestabiliserende bandage, der tillader bevægelighed i leddet, bruges fx ved ledbåndsskader i knæ.



Figur 3.18. Osteosyntesepprincipper. A-D) Intern fiksering med A) skrue og skinne, B) marvsøm, C) K-tråde (Kirschner-tråde), som er stive metaltråde i forskellige tykkelser, kombineret med cerclage, som er en blødere metaltråd. D) Cerclage som forstærkning eller alene. E) Ekstern fiksering med perkutane pinde og ekstern stabilisator.

- Der kan være behov for reposition før ovenstående

Eksamensopgave, ordinær eksamen 2023

Proksimal femur fraktur - hoftebrud

- a) Redegør for forekomst
- b) Redegør for patogenese og ætiologi
- c) Beskriv kort symptomer, fund og diagnostik
- d) Beskriv kort prognose samt byrde for patient og samfund

Eksamensopgave, ordinær eksamen 2023

Svarene er taget direkte fra modelbesvarelsen, som kan findes på Absalon

Proximal femur fraktur – hoftebrud

a) Redegør for forekomst

Ca. 10.000 tilfælde af proximal femur-fraktur pr. år.

b) Redegør for patogenese og ætiologi

Knoglebrudstyrken reduceres med alderen pga. osteoporose og forekomsten af fald stiger med alderen. Kraftpåvirkningen ved et fald fra stående stilling direkte på hoften andrager ca. 3500 N – mens brudstyrken ofte er reduceret til 2000-6000 N. Overvægt yder en vis beskyttelse pga. den forøgede tykkelse af bløddelene over hoften. Omvendt disponerer lav vægt. Lavt fysisk aktivitetsniveau tobak, alkohol og generelt alle faktorer der disponerer til knogleskørhed er risikofaktorer. Få procent af bruddene skyldes metastaser der svækker knoglen

Eksamensopgave, ordinær eksamen 2023

c) Beskriv kort symptomer, fund og diagnostik

Patienten kan ikke rejse sig og ligger ofte med benet udadroteret. Benet kan ligge oprykket og der er ofte rotationsømhed. Benet kan normal ikke løftes fra underlaget (med undtagelse af indkilede frakturer). Der foretages røntgenundersøgelse i to planer (subsidiært CT eller MR).

d) Beskriv kort prognose samt byrde for patient og samfund

Samlet set er mortaliteten indenfor det første år 15-25%. Særligt konkurrerende medicinske- og neurologiske lidelser forringer prognosen. Knap halvdelen af patienterne genvinder ikke den tidligere førlighed og omkring 10% kommer fra hospitalet til plejehjem. Den nedsatte førlighed og den betydelige rate af re-operationer medfører et betydeligt tab af livskvalitet for et stort antal ældre mennesker. Sygdommen er den enkelt-sygdom der repræsenterer flest indlæggelsesdøgn i DK (ca. 300.000 på årsbasis) og den samlede pris for behandling og rehabilitering er mere end 2 milliarder kroner.

Et par repetitionsspørgsmål

Hvilken er følgende lidelser fører typisk IKKE til symptomer fra leddene

1. Reumatoid artrit
2. Skulderluksation
3. Humerus fraktur
4. Morbus Bechterew

"Patogenese" betegner

1. Årsagen/årsagerne til en given sygdom
2. Komplikationerne til en given sygdom
3. Den biologiske mekanisme der fører til en given sygdom
4. Navnet på en ryglidelse

En af følgende er ikke et klassisk klinisk tegn på inflammation

1. Varme
2. Udslæt
3. Tab af funktion
4. Smerte

Reumatoid artrit er defineret som:

1. En steril artrit som udvikles efter en infektion
2. En inflammatorisk lidelse i de ægte led
3. Kronisk gigt i led hos psoriasispatienter
4. Et inflammatorisk angreb på et organ

**Modelbesvarelser til
eksamensopgaver ligger på
Absalon**

Tak for i dag 😊

Vi ses til "Neurologiske sygdomme"

I er altid velkomne til at skrive til mig, hvis I har spørgsmål

Mail: louise.heimdal@sund.ku.dk